

SEGUNDA PARTE

Forma 1 / Forma 1A

Instrucciones:

1. Esta prueba consta de 90 preguntas.
2. Dispondrá de un tiempo de **105 minutos** para responder.
3. Usted cuenta con una hoja de respuestas, la que podría estar al final de la prueba, caso en el que puede proceder a arrancarla. Debe contestar en ella, asegurándose de escribir su nombre y su RUT, con letra clara. **Debe escribir la forma de la prueba (ej. Forma 1)** en su hoja de respuesta.
4. Debe responder con lápiz mina HB N°2 o 2B, **ennegreciendo completamente la casilla correcta**.
5. Si se equivoca, la única forma de corregir es borrar con una goma y marcar la respuesta correcta.
6. **Solo se corregirá la hoja de respuestas**, así que asegúrese de contestarla a tiempo.
7. Las preguntas incorrectas **no descontarán puntaje**, se recomienda **no omitir**, ya que aquello tiende a bajar aún más el puntaje.
8. Puede rayar el cuadernillo de preguntas. Sin embargo, solo se corregirá la hoja de respuestas.
9. Al final de la prueba, debe entregar solo la hoja de respuestas, pudiendo quedarse con el cuadernillo de preguntas.
10. No se responderán dudas durante la prueba. Debe permanecer en silencio.
11. Asegúrese de pasar al baño antes de que inicie la prueba, ya que, durante esta, no podrá salir.
12. La copia está absolutamente prohibida. Tanto copiar, como entregar las respuestas al compañero será considerada una falta grave.
13. El simple hecho de tener encendido un celular o un smartwatch (reloj inteligente) u otro dispositivo electrónico, a través del cual sea posible copiar o enviar información, será considerado copia (en el Eunacom real ni siquiera se puede tener apagado, así que dele cumplimiento).
14. Si termina la prueba antes de que se acabe el tiempo, podrá entregar la hoja de respuestas y retirarse, sin hacer ruido ni hablar, hasta estar lo suficientemente lejos como para que quienes no han terminado no se vean afectados.
15. Las notas serán corregidas por la Universidad y serán subidas a la plataforma, apenas estén disponibles.

¡Les deseamos el mayor de los éxitos y mucha suerte!

(Habrá una segunda parte después de un breve recreo).

1) Una niña de 15 años ha presentado una serie de conflictos con sus familiares en el último tiempo, discutiendo con varios de ellos, de manera intensa. Además, está muy conversadora, incluso con extraños y ha tenido varios problemas en el colegio, debido a que interrumpe reiteradamente las clases y, cuando sus profesores la han hecho callar, responde de forma agresiva y los insulta. Duerme cerca de 5 horas al día, inició su vida sexual recientemente, sin protección y ha consumido marihuana en 3 oportunidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno por déficit atencional hiperactivo
- b) Trastorno de personalidad limítrofe
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno por consumo de sustancias

2) Una adolescente de 18 años consulta ambulatoriamente porque se siente ansiosa y agobiada. Además, refiere sentirse bastante avergonzado del mal rendimiento que ha tenido en su primer año de universidad, por lo que ha pensado en cambiarse de carrera, debido a que siente que ya no le gusta tanto lo que eligió estudiar. Refiere que en el colegio siempre había sido buena alumna, aunque reconoce que le costaba concentrarse y que, actualmente, procrastina sus estudios. Con frecuencia pierde las llaves y su celular y se distrae en las conversaciones cara a cara cuando son muy largas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno de ansiedad social
- c) Trastorno depresivo mayor
- d) Trastorno por déficit atencional
- e) Trastorno adaptativo

3) Un paciente de 35 años presenta dolor cervical súbito, mayor en el lado derecho, que inició mientras hacía deporte. El dolor es intenso y se irradia a la cara. Al examen neurológico, destaca ptosis y miosis del ojo derecho, sin alteraciones de la sensibilidad ni motilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cefalea en racimo (cluster headache)
- b) Parálisis del tercer par
- c) Disección carotídea
- d) Malformación vascular cerebral con compresión del tercer nervio craneal
- e) Infarto vertebro basilar

4) Un paciente de 25 años, con antecedente de trastorno bipolar de difícil manejo, en tratamiento con lamotrigina, litio, diazepam, sertralina y clorpromazina, presenta un cuadro de poliuria de cerca de 12 litros diarios, asociado a alta ingesta de agua. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, sodio: 154 mEq/L, potasio: 4,5 mEq/L, glicemia de ayunas: 80 mg/dl y hemograma normal. ¿Cuál de las siguientes opciones explica sus alteraciones?

- a) Polidipsia psicógena
- b) Consumo de lamotrigina
- c) Consumo de litio
- d) Consumo de clorpromazina
- e) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

5) Un paciente de 53 años es hospitalizado por una reacción alérgica grave, recibiendo adrenalina e hidrocortisona endovenosa. Durante la hospitalización se realizan múltiples exámenes, entre los que destacan glicemias de ayuno muy elevadas, en rangos entre 160 y 180 mg/dl. ¿Qué examen es más adecuado para determinar la etiología de esta alteración?

- a) Péptido C
- b) Anticuerpos anti GAD
- c) Hemoglobina glicosilada
- d) Test de tolerancia a la glucosa oral
- e) Tomografía axial computada pancreática

6) Un paciente de 84 años es traído a urgencia por familiares. Refieren que sus síntomas iniciaron hace 7 días, consistentes en tos con expectoración purulenta, sensación febril y disnea de esfuerzos. En las últimas noches se ha levantado algo agitado y anoche estuvo muy agitado, gritando que habían entrado extraterrestres en su casa y que lo querían matar. Al examen físico, tiene T°: 37,9°C, PA: 154/100, FC: 88x', FR: 25x', satura: 93% a FiO2 ambiente, tiene examen pulmonar con crepitaciones en la base derecha y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos sin soplos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Accidente vascular encefálico
- b) Delirium
- c) Epilepsia del lóbulo temporal
- d) Demencia tipo Alzheimer
- e) Esquizofrenia paranoide

7) Una paciente de 65 años, hipertensa y diabética de larga data, consulta por cefalea intensa de inicio súbito, asociado a dificultades para moverse. Al examen físico tiene una hemiparesia derecha, armónica, sin compromiso de conciencia y con conservación del lenguaje y la sensibilidad. No tiene alteraciones visuales. Como antecedente, ha sufrido golpes por caídas a repetición. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral media
- b) Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral anterior
- c) Hemorragia de la protuberancia anular o puente de Varolio
- d) Accidente vascular encefálico hemorrágico
- e) Accidente vascular de tipo lacunar

8) Un paciente de 69 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico intenso EVA 10/10, de carácter lancinante y que se irradia a cuello y dorso. A lo anterior se agregó dolor intenso en la extremidad superior izquierda. Al examen físico tiene FC: 120x', PA: 200/140 mmHg, ritmo regular en dos tiempos, sin soplos, murmullo pulmonar bilateral conservado, sin otros ruidos, extremidad superior izquierda con disminución del pulso radial y frialdad de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Pericarditis aguda
- b) Disección aórtica
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Infarto agudo al miocardio
- e) Embolias cardíacas

9) Una paciente de 20 años es encontrada inconsciente en el baño por sus familiares, con el piloto del calefont apagado, por lo que es llevada al servicio de urgencia de inmediato, recuperándose parcialmente en el camino. Al examen físico está consciente, responde al interrogatorio y coopera, aunque está soporosa y se queja de muchas náuseas y cefalea intensa. Satura 97% a FiO2 ambiental, tiene frecuencia cardíaca de 90x' y presión arterial 146/92 mmHg. Su examen cardiopulmonar resulta normal. Cuál es el examen de elección para

- a) Radiografía de tórax
- b) Resonancia magnética nuclear de cerebro
- c) Carboxihemoglobina
- d) Gases en sangre arterial
- e) TAC de cerebro sin contraste

10) Una niña de 13 años ha presentado diez episodios de angustia muy intensa, asociadas a sensación de muerte, disnea, vértigo, ganas de ir corriendo a su casa, temor a estar volviéndose loca y llanto descontrolado, todo lo que ha afectado seriamente su calidad de vida. Además. Sus padres han debido ir a buscarla en 3 oportunidades al colegio en las últimas dos semanas, debido a estos síntomas. No presenta síntomas depresivos, aunque su autoestima se ha visto mermada por la situación. Su examen físico es normal ¿Cuál es el tratamiento más importante para esta paciente?

- a) Sertralina
- b) Quetiapina
- c) Ácido valproico
- d) Alprazolam
- e) Diazepam

11) Un hombre de 59 años, fumador, presenta un accidente vascular encefálico, que se maneja rápidamente, por lo que se recupera sin dejar secuelas. Posteriormente, se realiza ecografía Doppler carotídea como estudio de fuente embólica, que no muestra alteraciones arteriales, pero sí identifica la presencia de un nódulo tiroideo de 1 cm de diámetro, de aspecto quístico, bien delimitado y capsulado. Se solicitan pruebas tiroideas que muestran TSH: 2,1 microU/ml (VN: 0,5 a 5,0) y T4 libre que resulta 1,2 ng/dl (VN: 0,9 a 2,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del nódulo tiroideo?

- a) Realizar punción con aguja fina
- b) Controlar en 6 meses con nueva ecografía
- c) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
- d) Iniciar levotiroxina
- e) Realizar biopsia excisional quirúrgica

12) Una paciente, con antecedente de tiroidectomía total por cáncer de tiroides, con hipoparatiroidismo postquirúrgico, en tratamiento con levotiroxina 100 ug al día y con calcio 450 mg más vitamina D3 175 UI cada 8 horas, presenta diarrea acuosa, desde hace 4 días, a lo que se ha agregado astenia y debilidad, . Al examen físico se constatan signos vitales dentro del rango normal, examen cardiopulmonar normal, examen abdominal con abdomen blando, depresible, sensible a la palpación profunda, examen neurológico con signo de Chvostek y debilidad de las 4 extremidades, con reflejos osteotendíneos claros. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar calcio intravenoso
- b) Aumentar la dosis de levotiroxina
- c) Administrar suero fisiológico intravenoso
- d) Administrar suero Ringer lactato intravenoso
- e) Administrar bicarbonato de sodio endovenoso

13) Una paciente de 31 años, cursando un embarazo de 28 semanas, presenta síntomas de parto prematuro, por lo que se le deja licencia médica por 2 semanas. Está afiliada a una Isapre y a una Mutual. ¿Qué institución es la encargada del financiamiento de esta licencia?

- a) Fondo Nacional de Salud (Fonasa)
- b) Institución de Salud Previsional (Isapre)
- c) Caja de Compensación
- d) Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin)
- e) Fondo Único de Prestaciones Familiares, con cargo Estatal

14) Una paciente de 73 años, diabética e hipertensa, con insuficiencia renal crónica, en tratamiento con insulina NPH, losartán, amlodipino y atenolol, presenta malestar general, seguido de síncope en varias oportunidades en el día de hoy, por lo que es llevada a la urgencia. Al examen físico tiene FC: 30x', PA: 70/36 mmHg, sopor profundo, sudoración, ausencia de signos focales. Se solicitan exámenes de laboratorio entre los que destaca Na+: 130 mEq/L, K+: 8,2 mEq/L, Cl-: 98 mEq/L, pH: 7,29, HCO3-: 18 mEq/L, glicemia capilar: 180 mg/dl. El resto de la analítica está pendiente. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Instalar marcapasos externo transitorio
- b) Administrar gluconato de calcio endovenoso
- c) Administrar atropina
- d) Hemodiálisis de urgencia
- e) Administrar suero fisiológico endovenoso

15) Un paciente de 56 años, diabético en tratamiento con metformina 500 mg/8horas, con hipertensión de reciente diagnóstico, se realiza exámenes de control, que muestran creatinina plasmática: 0,9 mg/dl, BUN: 18 mg/dl, electrolitos plasmáticos: Na+: 141 mEq/L y K+: 4,1 mEq/L, RAC (relación albuminuria / creatininuria): 2,6 y hemoglobina glicosilada: 6,9%. ¿Qué fármaco es el más adecuado para el tratamiento de su hipertensión arterial?

- a) Hidralacina
- b) Espironolactona
- c) Amlodipino
- d) Atenolol
- e) Valsartán

16) Una paciente de 68 años, con antecedente de hipertensión y cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con losartán y clortalidona, que, además, tiene fibrilación auricular crónica, en tratamiento con amiodarona y rivaroxabán, consulta por un cuadro de disnea progresiva que se ha instalado en los últimos meses, que actualmente es de medianos esfuerzos y se asocia a tos seca, mayor en la noche. Al examen físico tiene pulso regular a 74x', PA: 130/80 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales, examen cardíaco: RR2T sin soplos, con abdomen y extremidades sin alteraciones. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia):



¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar salbutamol
- b) Agregar espironolactona
- c) Suspender el rivaroxabán
- d) Suspender la amiodarona
- e) Agregar furosemida

17) Una paciente de 45 años, con antecedente de infecciones respiratorias a repetición en la infancia, presenta broncorrea de cerca de 300cc al día, mayor en la mañana, asociada a disnea de esfuerzos y tos con expectoración. Además, refiere cuadros de exacerbación de sus síntomas que ocurren varias veces al año, por lo que usa antibióticos. Al examen físico tiene signos vitales dentro de rango normal y, en la auscultación pulmonar se objetiva espiración prolongada, además de auscultarse estertores y sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: www.sciencephoto.com):



¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el diagnóstico?

- a) Recuento de inmunoglobulina A, G y M
- b) TAC de tórax
- c) Baciloscopías y cultivo para micobacterias
- d) Lavado bronquioalveolar
- e) Broncoscopía

18) Un hombre de 43 años consulta porque, desde hace 15 días, ha presentado angustia, desasosiego, insomnio y malestar general. Refiere, además, cefalea occipital, irradiada al cuello que es peor en las tardes. Refiere que los síntomas iniciaron después de que le comunicaron en su trabajo que sería trasladado a otra ciudad, por lo que deberá cambiarse de casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno de somatización
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno de adaptación
- d) Trastorno de angustia
- e) Episodio depresivo mayor

19) Un paciente de 48 años, que trabaja como operador de maquinaria de la minería, consulta por disnea de esfuerzo de 2 años de evolución, que ha progresado en el último tiempo, asociado a tos con expectoración mucosa ocasional. Al examen físico tiene PA: 108/72 mmHg, FC: 70x', aumento del diámetro anteroposterior del tórax, espiración prolongada y, a la auscultación pulmonar, se oyen sibilancias bilaterales. Se realiza espirometría que muestra lo siguiente:

	VEF1	CVF	VEF1/CVF
Basal	2.532 cc (59%)	4.870 cc (99%)	52%
Postbroncodilatador	2.659 cc (62%)	5.017 cc (102%)	53%

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- b) Asma bronquial
- c) Hipertensión pulmonar
- d) Insuficiencia cardíaca
- e) Fibrosis pulmonar

20) Un hombre de 33 años, sin antecedentes de importancia, despierta con hipoacusia del oído izquierdo, asociado a tinitus, sin otros síntomas. No ha presentado vértigo y su otoscopia no muestra alteraciones. Su examen neurológico no aporta nueva información. ¿Cuál es el examen inicial para evaluar a este paciente?

- a) Impedanciometría
- b) TAC de oído
- c) TAC de cerebro
- d) Prueba calórica
- e) Audiometría

21) Una paciente de 35 años, con antecedente de 3 abscesos de Bartholino, que han requerido drenaje quirúrgico, consulta por dolor en la zona vulvar de dos días de evolución. Al examen ginecológico, se observa aumento de volumen de 3 cm, en relación al labio menor derecho, a tensión, que es doloroso a la palpación y no presenta signos inflamatorios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Bartholinocistoneostomía
- b) Evacuación por punción
- c) Vaciamiento por incisión
- d) Antibióticos orales
- e) Baños de asiento y analgésicos

22) Una paciente de 32 años, se realiza citología cervical, que es informada como “presencia de células escamosas atípicas, sugerentes de NIE 3”. Se realiza colposcopia que no muestra lesiones y curetaje endocervical que es informado como “tejido endocervical normal”. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir el curetaje endocervical
- b) Controlar con nuevo Papanicolaou en un año
- c) Realizar histerectomía
- d) Realizar conización cervical
- e) Realizar legrado y biopsia endometrial

23) Una paciente de 24 años, usuaria de anticonceptivos orales, cuya última regla fue hace 8 días, consulta por dolor en la fosa ilíaca derecha, de inicio súbito, intenso, que se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios, en una oportunidad. Al examen físico, tiene FC: 88x', PA: 120/78 mmHg, examen abdominal con dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha y del hipogastrio. Al examen ginecológico, además, se palpa una masa anexial derecha de 6 cm. Se solicita ecografía transvaginal, que visualiza útero de tamaño y paredes normales, endometrio de 6 mm de diámetro, presencia de una lesión anexial derecha quística de 6 cm, sin líquido libre, además, no es posible visualizar el apéndice cecal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Absceso tubo ovárico
- b) Apendicitis aguda
- c) Quiste ovárico torcido
- d) Embarazo ectópico
- e) Vólvulo de ciego

24) Un niño de 3 años acude a control sano. Su madre refiere que tiene estrechez del prepucio y, al examen físico, se confirma que el prepucio es irreductible . ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Aplicar ungüento antibiótico
- b) Realizar tracción manual forzada del prepucio
- c) Realizar circuncisión
- d) Aplicar ungüento de corticoide tópico
- e) Controlar en un año

25) Un lactante de 1 mes de vida, acude a control. Al examen físico, presenta estrabismo intermitente y asimétrico de ambos ojos. El resto de la inspección ocular es normal. Su crecimiento pondoestatural es normal, al igual que su desarrollo psicomotor y el resto de su examen físico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Derivar a oftalmólogo
- b) Mantener los controles habituales del lactante
- c) Solicitar RMN de cerebro
- d) Realizar fondo de ojo
- e) Indicar parche ocular alternante

26) Usted evalúa a un recién nacido de término, que está en buenas condiciones, se alimenta con leche materna y tiene examen neurológico normal. Al examen físico segmentario no se palpa ninguno de los testículos en el escroto ni en la zona inguinal. Su pene mide 2 cm de largo. Además de solicitar una ecografía inguinal, la conducta más adecuada es:

- a) Controlar en un mes
- b) Solicitar niveles plasmáticos de testosterona
- c) Realizar exploración quirúrgica en este momento, mediante laparoscopia
- d) Solicitar cariograma
- e) Planificar cirugía de descenso testicular al cumplir un año

27) Un niño de 14 meses presenta fiebre hasta 38,6°C desde hace dos días. El examen físico no identifica un foco, por lo que se solicitan exámenes de orina, con muestra obtenida por recolector, que muestra sedimento con 10 glóbulos blancos por campo, 2 a 4 glóbulos rojos por campo, células epiteliales en regular cantidad, bacterias en moderada cantidad y citoquímico con nitritos negativos, ausencia de glucosuria y proteinuria, ausencia de cristales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar cintigrafía renal
- b) Solicitar ecografía renal y vesical
- c) Solicitar examen de orina por sondeo
- d) Iniciar cefadroxilo oral
- e) Iniciar ceftriaxona endovenosa

28) Un niño de 5 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre, cefalea, rinorrea purulenta abundante, descarga posterior y obstrucción nasal. Desde hace poco se agrega mayor fiebre, además de edema y eritema periocular derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Absceso frontal
- b) Conjuntivitis bacteriana
- c) Sinusitis maxilar
- d) Absceso periorbitario
- e) Conjuntivitis viral

29) Una mujer de 24 años, parvularia, cursando embarazo de 18 semanas, estuvo en contacto con un niño, que fue recientemente diagnosticado de varicela. Ella refiere que nunca ha tenido varicela. No presenta síntomas ni alteraciones en su examen físico u obstétrico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar aciclovir a la madre
- b) Solicitar serología para la varicela a la madre
- c) Administrar gamaglobulina hiperinmune contra varicela a la madre
- d) Vacunar contra la varicela
- e) Observar evolución

30) Un paciente de 20 años, con diagnóstico de trastorno bipolar, en tratamiento con risperidona y litio, desde hace 3 meses, consulta por un cuadro de una semana de evolución de náuseas, malestar general y tendencia al sopor. Al examen físico se constata desorientado, con temblor de extremidades superiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca litemia de 2,2 mEq/L (rango normal: 0,6 a 1,2 mEq/L) y creatininemia: 1,3 mg/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Plasmaféresis
- b) Hemodiálisis
- c) Alcalinizar la orina
- d) Administrar suero fisiológico endovenoso
- e) Diazepam endovenosa

31) Un paciente de 37 años es diagnosticado de hipertensión hace un año, en tratamiento con enalapril, atenolol e hidroclorotiazida, a pesar de lo cual ha presentado valores tensionales sobre el objetivo, con varias tomas sobre 160/110 mmHg. Además, aqueja astenia, debilidad de las extremidades inferiores y cefalea frecuente. Se solicitan exámenes generales, que muestran TSH: 6,0 UI/L, creatinina: 1,2 mg/dl, sodio: 142 mEq/L, potasio: 3,1 mEq/L, hemograma normal y glicemia de ayuno: 72 mg/dl. Se solicita TAC de abdomen, que muestra un tumor suprarrenal derecho, de 2 cm de diámetro, sólido y homogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Feocromocitoma
- b) Hipertensión esencial
- c) Hipertensión renovascular
- d) Hipertensión asociada a insuficiencia renal
- e) Hiperaldosteronismo primario

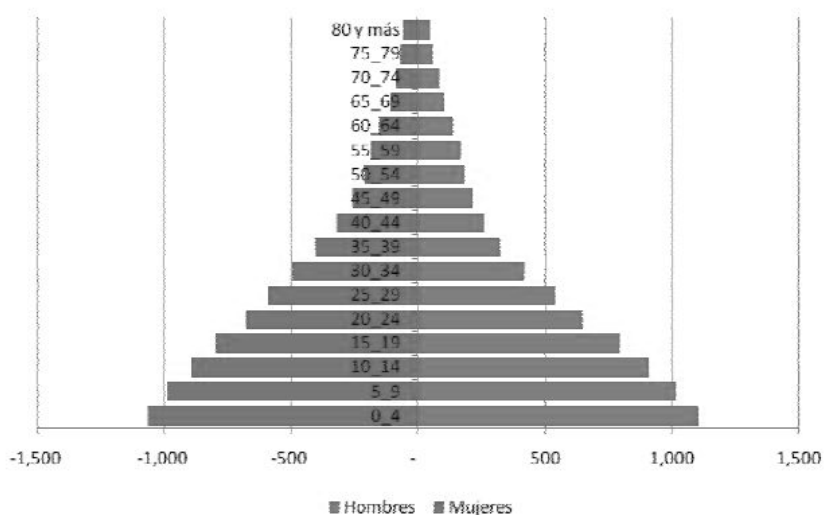
32) ¿Cuál de los siguientes indicadores es de elección para evaluar la efectividad de una campaña de vacunación contra la influenza?

- a) Mortalidad mensual por influenza
- b) Tasa de cobertura de vacunación
- c) Incidencia semanal por influenza
- d) Prevalencia de influenza
- e) Letalidad mensual de la influenza

33) Un paciente de 76 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, presenta un cuadro de 2 días de evolución de debilidad y malestar general, al que se agrega obnubilación de conciencia y tendencia al sopor. Al examen físico se aprecia desorientado, con sopor profundo, sin focalidad neurológica, tiene FC: 80x', PA: 150/100 mmHg y FR: 16x'. El examen torácico y abdominal no aporta mayor información. Se solicitan electrolitos plasmáticos que muestran sodio: 148 mEq/L, potasio: 5 mEq/L, calcio: 14,8 mg/dl y otros exámenes de sangre que muestran creatinina: 1,4 mg/dl, GOT: 50 UI/l, GPT: 46 UI/L, albúmina: 3,8 g/dl, bilirrubina: 1,1 mg/dl y APE: 200 ng/ml. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Administrar calcitonina endovenosa
- b) Realizar hemodiálisis de urgencia
- c) Administrar ácido zolendrónico endovenoso
- d) Administrar gluconato de calcio endovenoso
- e) Administrar suero fisiológico endovenoso

34) Un país presenta la siguiente pirámide poblacional:



¿En qué tipo de medidas se deben focalizar las intervenciones de salud pública?

- a) Prevenir y tratar oportunamente el cáncer
- b) Prevención del consumo de drogas, cigarrillo y alcohol
- c) Planificación familiar, prevención de la desnutrición, saneamiento básico y vacunación
- d) Fomentar la actividad física y prevenir el sedentarismo y la obesidad
- e) Detección y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles

35) Una paciente de 18 años, diabética tipo 1 en tratamiento con insulina glargina e insulina cristalina en esquema intensificado, consulta por un cuadro, que inició hace 2 meses, caracterizado por deposiciones líquidas frecuentes, sin mucosidad, asociadas a malestar abdominal y baja de peso de 4 kilogramos. Al examen físico, se aprecia pálida, tiene signos vitales normales y su abdomen es blando, depresible, sensible a la palpación profunda, sin irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes a la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad celíaca
- b) Síndrome de intestino irritable, asociado a diarrea
- c) Enteropatía perdedora de proteínas
- d) Enfermedad inflamatoria intestinal
- e) Diarrea viral

36) Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dolor epigástrico y en hipocondrio derecho, de dos días de evolución, asociado a náuseas y malestar general. Al examen físico se ve decaída, con FC: 105x', PA: 148/99 mmHg, FR: 15x', examen abdominal con dolor a la palpación del epigastrio y el hipocondrio derecho, sin signos peritoneales. Se solicitan exámenes de sangre que muestran hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,9 g/dl, blancos: 6.800 por mm³, plaquetas: 80.000 por mm³, bilirrubina plasmática: 2,0 mg/dl, con fracción indirecta: 1,6 mg/dl y fracción directa: 0,4 mg/dl, GOT: 320 UI/L, GPT: 240 UI/L. La ecografía abdominal muestra presencia de litiasis vesicular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Pancreatitis aguda
- b) Hepatitis viral
- c) Colecistitis aguda
- d) Colestasia intrahepática
- e) Síndrome de HELLP

37) Una paciente de 27 años consulta por deposiciones diarreicas de 3 semanas de evolución, asociadas a mucho pujo y tenesmo rectal. Refiere rectorragia ocasional escasa. Su examen físico muestra T°: 37°C, PA: 122/78 mmHg, FC: 72x', abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación hipogástrica y fosa iliaca izquierda. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Test de sangre oculta en deposiciones
- b) Parasitológico de deposiciones
- c) Colonoscopia
- d) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
- e) PCR para *Clostridioides difficile*

38) Un paciente de 58 años presenta dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a náuseas y distensión abdominal. Sus últimas deposiciones fueron hace dos días y no ha eliminado gases por ano desde ayer. Sus signos vitales muestran T°: 36,8°C, FC: 96x', PA: 144/92 mmHg, abdomen distendido, doloroso a la palpación, con signo Blumberg esbozado. En la auscultación abdominal, tiene bazuqueo intestinal y disminución de los ruidos hidroaéreos. Como antecedentes médico-quirúrgicos, es diabético, usa metformina y aspirina y se realizó apendicectomía hace 10 años. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Vólvulo de sigmoides
- b) Isquemia mesentérica
- c) Gastroenteritis aguda
- d) Obstrucción intestinal
- e) Cáncer de colon perforado

39) Una paciente de 35 años consulta por metrorragia abundante de 6 horas de evolución. Al examen físico está orientada, sudorosa, tiene presión arterial: 88/58 mmHg, frecuencia cardíaca: 120x', se observa pálida y tiene frialdad de extremidades. En el examen ginecológico, se realiza especuloscopia que objetiva que la sangre proviene del orificio cervical externo y se palpa útero grávido. Se solicitan exámenes, entre los que destaca beta-HCG, que resulta positiva y análisis hematológico, que muestra anemia con hemoglobina de 10 g/dl. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra contenido endometrial de 19mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo?

- a) Histerectomía
- b) Vaciamiento uterino
- c) Ácido tranexámico intravenosa
- d) Oxitocina intravenosa
- e) Misoprostol intrarrectal

40) Una paciente de 45 años consulta por dolores articulares en muñecas, articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos, asociado a dolor en el codo derecho y la rodilla izquierda. Además, se queja de rigidez matinal, que dura cerca de 4 horas. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, eritema y aumento de la temperatura local de varias de las articulaciones descritas. ¿Cuál es el examen más específico para el diagnóstico de esta patología?

- a) Anticuerpos anti DNA nativo
- b) Anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos
- c) Anticuerpos antinucleares
- d) Anticuerpos anti-CCP
- e) HLA B27

41) Una paciente de 62 años sufre una caída a nivel, sufriendo una fractura del extremo distal del radio izquierdo, la que es manejada ortopédicamente, con un yeso braquiopalmar. A las 5 horas, evoluciona con intenso dolor, EVA 10/10, que no responde a la analgesia y se asocia a dificultades para mover los dedos. Al examen físico, se objetivan dedos con llene capilar enlentecido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de dolor locorregional complejo
- b) Lesión de la arteria radial
- c) Trombosis venosa profunda
- d) Compresión del nervio mediano
- e) Síndrome compartimental

42) Un paciente de 70 años ha presentado 3 episodios de dolor y aumento de volumen de la rodilla derecha, que le impide o dificulta la marcha, pero que ha respondido a analgésicos. Acude nuevamente por los mismos síntomas, objetivándose artritis de rodilla derecha, con signos de derrame articular, por lo que se punciona, dando salida a un líquido articular inflamatorio, con abundantes cristales de pirofosfato de calcio, sin bacterias. ¿Qué fármaco es más adecuado para evitar recurrencias?

- a) Colchicina
- b) Naproxeno
- c) Alopurinol
- d) Hidroclorotiazida
- e) Metotrexato

43) Un paciente de 78 años, consulta por lumbago de un mes de evolución, progresivo e intenso, que no ha respondido bien a analgésicos. En su examen físico se observa con IMC: 20, FC: 75x'. PA: 126/86 mmHg, cabeza y cuello sin alteraciones, cardiopulmonar normal y examen lumbar con limitación de los movimientos, por dolor. Trae exámenes, que muestran hemograma con hematocrito: 30%, hemoglobina: 10,5 g/dl, plaquetas: 88.000 por mm³, glóbulos blancos: 4.300 por mm³, con fórmula diferencial normal, VHS: 78 mm/h, creatinina: 2,2 mg/dl, natremia: 135 mEq/, potasemia: calcemia 10,5 mg/dl, proteínas totales: 8,9 g/dl, albúmina: 2,9 g/dl. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a) Electroforesis de proteínas en sangre
- b) Densitometría ósea
- c) Radiografía de huesos largos y cráneo
- d) Estudio citogenético de médula ósea
- e) Niveles plasmáticos de vitamina B12

44) Un paciente de 70 años, desde hace 2 semanas ha presentado marcado malestar general y astenia, notando aparición de equimosis en las piernas. En su examen físico, se aprecia pálido, con petequias generalizadas y equimosis. Además, se palpan adenopatías en cuello e ingle. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8,1 g/dl, hematocrito: 24%, glóbulos blancos: 45.000 por mm³, con 60% de blastos linfoides. Su otros exámenes muestran glicemia: 160 mg/dl, Na⁺: 136 mEq/L, K⁺: 6,3 mEq/L, ácido úrico: 12,2 mg/dl, fósforo: 7,1 mg/dl, creatinina: 1,3 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Imipenem
- b) Heparina
- c) Hidrocortisona
- d) Sulfonato de poliestireno
- e) Quimioterapia

45) Un recién nacido, presenta un cefalohematoma de gran tamaño, al momento de nacer. Además, presenta hematoma del sitio de punción de la muestra venosa. Sus padres son asintomáticos, pero uno de sus tíos murió en el periodo neonatal por hemorragia intracraneal. Entre sus exámenes, destaca TP: 70%, TTPA: 65 segundos, hemograma con hematocrito 50%, blancos: 8.400 por mm³ y plaquetas: 350.000 por mm³. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Agregometría plaquetaria
- b) Factores de coagulación VIII y IX
- c) Estudio de trombofilia
- d) Biopsia de médula ósea
- e) Frotis de sangre periférica

46) Un lactante de 15 meses fue sano hasta los 6 meses de edad, pero, después de ello, ha presentado candidiasis oral a repetición, cuatro otitis medias aguda y dos neumonías que han requerido hospitalización. ¿Cuál es la causa más probable de su inmunodepresión?

- a) Inmunodeficiencia humoral
- b) Inmunodeficiencia combinada severa
- c) Alteración de la fagocitosis
- d) Déficit de complemento
- e) Inmunodeficiencia celular

47) Una paciente de 63 años presenta dolor en articulaciones de las manos, mayores en las articulaciones interfalángicas distales y proximales, asociadas a rigidez matinal de 5 minutos. Además, refiere dificultades para las actividades que requieren mayor prensión de las manos. Se realiza radiografía de manos, que muestra disminución del espacio articular, con esclerosis subcondral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Artritis reumatoide
- b) Artritis psoriática
- c) Osteoartritis
- d) Osteoporosis
- e) Artritis reactiva

48) Una paciente de 72 años presenta aumento de volumen, en relación a la cara interna del muslo derecho, que aumentado de tamaño en los últimos meses. Al examen físico, se aprecia una tumoración de 10 cm de diámetro, de consistencia similar al músculo. Se realiza ecografía, que muestra un tumor sólido de 12 cm, en relación al músculo recto femoral derecho. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

- a) Radiografía de fémur
- b) PET scan
- c) Hemograma y biopsia de médula ósea
- d) Tomografía axial computada de muslo
- e) Resonancia magnética nuclear de muslo

49) Un paciente de 17 años consulta por un cuadro que inició hace 12 días, consistente en congestión nasal, rinorrea mucosa abundante y odinofagia. En los últimos días la rinorrea se vuelve purulenta y empeoran los síntomas, agregándose sensación febril y tos seca mayor en las noches. En el examen físico se constata fiebre de 38,2°C, FC: 78x', FR: 12x', se observa faringe eritematosa, con descarga posterior y se observa rinorrea purulenta en ambas fosas nasales. Su examen cardiopulmonar es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Amoxicilina oral por 7 días
- b) Claritromicina oral por 10 días
- c) Aseo con suero fisiológico
- d) Corticoides orales por 7 días
- e) Antihistamínicos orales por 7 días

50) Un niño de 3 meses de edad acude a control de niño sano, con una radiografía anteroposterior de pelvis, que muestra ángulo acetabular de 28° a derecha y 26° a izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Correas de Pavlik
- b) Derivar a traumatología
- c) Usar doble pañal
- d) Mantener el control habitual
- e) Solicitar ecografía de caderas

51) Una paciente de 65 años, con IMC: 34, consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, el dolor le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. El diagnóstico más probable es:

- a) Coxartrosis
- b) Fractura incompleta de cadera por estrés
- c) Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2
- d) Bursitis trocantérica
- e) Síndrome de la fascia lata rígida

52) Una lactante de 6 meses, presenta eritema del pañal, desde hace 7 días, que no ha mejorado a pesar de realizar cambios frecuentes del pañal y de aplicar óxido de zinc. Usa pañal desechable y se alimenta con lactancia materna exclusiva. Al examen físico, se aprecia lo siguiente (fuente: <https://idermumbert.com/dermatologia>):



¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Mupirocina tópica
- b) Betametasona tópica
- c) Vaselina tópica
- d) Clotrimazol tópico
- e) Pimecrolimus tópico

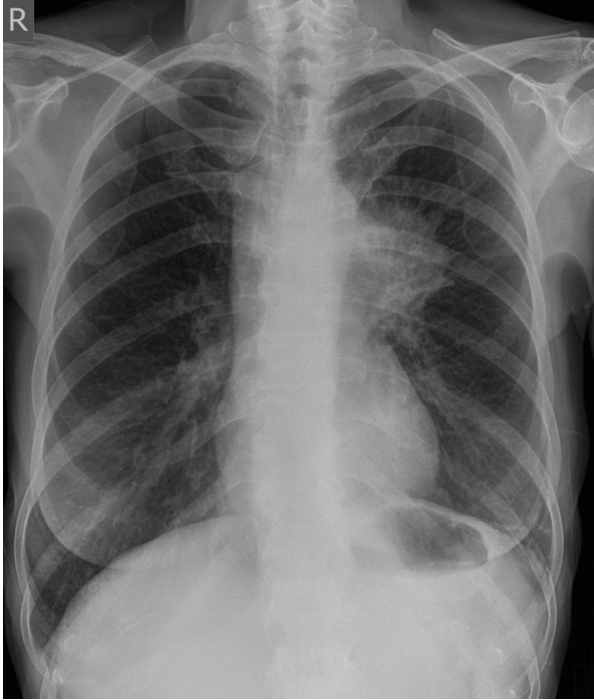
53) Un paciente de 83 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, institucionalizado, presenta lesiones en las piernas, de 4 meses de evolución, que se muestran a continuación (www.mdsaude.com):



¿Cuál es el la conducta más adecuada?

- a) Mupirocina tópica
- b) Flucloxacilina oral
- c) Vendas elásticas
- d) Biopsiar las lesiones
- e) Vaselina más betametasona tópica

54) Una paciente de 63 años, con antecedente de diabetes e hipertensión mal controladas, fumadora de 40 paquetes años y alcohólica activa, consulta por dolor torácico izquierdo, que aumenta con los movimientos respiratorios, asociado a tos con expectoración mucosa, que, en ocasiones es hemoptoica. Ha bajado de peso y refiere disnea de esfuerzos desde hace algunos meses. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 65x', PA: 150/98 mmHg, saturación de oxígeno por pulsometría: 95% a FiO2 ambiental, examen pulmonar con murmullo vesicular simétrico, con escasos crépitos a izquierda y, además, refiere dolor a la palpación de quinto arco costal izquierdo. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Absceso pulmonar
- b) Neumonía neumocócica
- c) Tuberculosis pulmonar
- d) Disección aórtica
- e) Cáncer pulmonar

55) Un paciente de 80 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, en tratamiento con hormonoterapia, presenta deterioro súbito del estado respiratorio, evolucionando con taquicardia y desaturación arterial. Se solicita angioTAC, que demuestra un tromboembolismo pulmonar derecho, por lo que se inicia terapia anticoagulante, sin embargo, evoluciona en malas condiciones generales, cayendo en insuficiencia respiratoria, colapso circulatorio y, finalmente, ausencia de pulso y respiración, por lo que se realiza reanimación avanzada, con múltiples desfibrilaciones y adrenalina, sin respuesta, por lo que se declara la muerte. ¿Cuál de las siguientes debe ser la causa de muerte inmediata en el certificado de defunción?

- a) Cáncer de próstata
- b) Insuficiencia respiratoria aguda
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Falla multiorgánica
- e) Fibrilación ventricular

56) Una paciente de 27 años consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, asociado a malestar general, astenia y náuseas, a lo que recientemente se agrega ictericia. Al examen físico, destaca ictericia de escleras, pulso regular a 76x', PA: 110/70 mmHg, abdomen blando, depresible, pero con dolor a la palpación del epigastrio e hipocondrio derecho, sin visceromegalia ni signos peritoneales. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran tiempo de protrombinemia: 70%, SGOT: 512 UI/L, SGPT: 356 UI/L, FA: 230 UI/L, GGT: 120 UI/L, albúmina: 3,8 g/dl, bilirrubina total: 4 mg/dl, con 35% de bilirrubina directa. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Ecografía abdominal
- b) TAC abdominal
- c) Endoscopia digestiva alta
- d) Colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear
- e) Serología para virus hepatitis

57) Un paciente de 80 años presenta una clínica de 3 semanas de evolución de astenia, prurito e ictericia, asociada a malestar epigástrico. Además, refiere que ha bajado de peso en los últimos meses. Su examen físico muestra ictericia de piel y escleras, IMC: 19, signos vitales dentro de límites normales y examen abdominal que no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina plasmática: 12,4 mg/dl, con bilirrubina directa: 7,7 mg/dl, GOT: 120 UI/L, GPT: 89 UI/L, fosfatasas alcalinas: 870 UI/L y GGT: 688 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Coledocolitiasis
- b) Cáncer ampular
- c) Cáncer de páncreas
- d) Colangiocarcinoma
- e) Colangitis aguda

58) Un paciente de 56 años es encontrado inconsciente en la vía pública, con hálito alcohólico, con varios golpes. Se hospitaliza para manejo de sus lesiones, sin embargo, a las 48 horas presenta gran agitación, diciendo que lo tienen encerrado en la cárcel y no lo dejan escapar. Se observa desorientado, tembloroso y no coopera con el interrogatorio. ¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo?

- a) Tiamina
- b) Haloperidol
- c) Lorazepam
- d) Clorpromazina
- e) Risperidona

59) Un paciente de 82 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina y dieta, acude a control, con glicemia de ayuno de 355 mg/dl, hemoglobina glicosilada de 9,5%. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de su diabetes?

- a) Agregar glibenclamida
- b) Agregar sitagliptina
- c) Iniciar insulina NPH
- d) Iniciar insulina glargina
- e) Iniciar liraglutide

60) Un recién nacido de término, con antecedente de madre con preclamsia, pesa 2.600 gramos al nacer. ¿Cuál es la complicación más frecuente durante las primeras horas de vida?

- a) Hipoglicemia
- b) Sepsis
- c) Hiperbilirrubinemia
- d) Anemia
- e) Distrés respiratorio

61) Una paciente de 26 años, cursando un embarazo de 41 semanas, inicia trabajo de parto. Al examen tienen 4 contracciones cada 10 minutos, dilatación cervical de 6 cm El registro fetal muestra desaceleraciones variables. Al romperse las membranas sale meconio espeso. El nacimiento se produce algunos minutos después, obteniéndose un recién nacido hiporreactivo e hipotónico. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Poner bajo calor radiante, administrar oxígeno, secar y reevaluar en 30 segundos
- b) Realizar intubación orotraqueal y aspirar la vía aérea
- c) Realizar ventilación a presión positiva
- d) Realizar compresiones torácicas
- e) Aspirar el contenido gástrico

62) Una niña de 6 años, desde hace dos horas presenta edema de los labios, más aparición de múltiples lesiones habonosas y pseudopapulares generalizadas. Además, presenta dolor abdominal persistente y náuseas. ¿Cuál es el fármaco que debe recibir inmediatamente?

- a) Prednisona
- b) Clorfenamina
- c) Gluconato de calcio
- d) Salbutamol
- e) Adrenalina

63) ¿Cuál de los siguientes indicadores es una variable de la demografía dinámica?

- a) Tasa de fecundidad
- b) Índice de población urbana / rural
- c) Tasa de masculinidad
- d) Distribución etárea
- e) Tasa de mortalidad infantil

64) Un paciente de 15 años sufre una torsión de rodilla derecha, siendo diagnosticado de un esguince, por lo que se indica inmovilizador de rodilla. Sin embargo, no mejora luego de 10 días, sino que, por el contrario, el dolor ha ido en aumento y no responde bien a la analgesia con naproxeno y ketorolaco. Al examen físico, presenta dolor a los movimientos de flexoextensión de la rodilla y a la palpación en la zona proximal y medial de la tibia derecha, sin signo de bostezo al varo ni al valgo. Se solicita una radiografía de rodilla, que muestra aspecto heterogéneo de la tibia proximal, con reacción perióstica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Osteosarcoma
- b) Fractura
- c) Osteomielitis
- d) Esguince severo de rodilla
- e) Hematoma en organización

65) Un niño de 6 años fue operado de un tumor cerebral hace 7 días. Desde entonces ha presentado volúmenes urinarios aumentados, de 4,5 litros al día. Se solicitan exámenes de sangre, que muestran glicemia de ayuno: 103 mg/dl, Na+: 154 mEq/L, K+: 4,9 mEq/L. Orina con sedimento normal, densidad 1.005 g/L y osmolaridad urinaria: 100 mOsm/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome perdedor de sal cerebral
- b) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
- c) Insuficiencia suprarrenal
- d) Diabetes insípida
- e) Diabetes mellitus

66) Una niña de 2 años comienza con estrabismo, con desviación hacia lateral del ojo izquierdo. A la inspección ocular, se observa leucocoria izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Retinoblastoma
- b) Glaucoma congénito
- c) Catarata congénita
- d) Retinopatía del prematuro
- e) Tumor de órbita

67) Un paciente de 66 años, diabético e hipertenso, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 1 año, se realiza perfil lipídico, que muestra triglicéridos: 325 mg/dl, colesterol LDL: 125 mg/dl, colesterol HDL: 30, colesterol total: 220 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo de su dislipidemia?

- a) Atorvastatina 20 mg/día
- b) Fenofibrato 160 mg/día
- c) Gemfibrozilo 600 mg cada 12 horas
- d) Aporte de ácidos grasos omega 3
- e) Rosuvastatina 20 mg/día

68) Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, fumador activo, consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico opresivo e intenso, de 2 horas de evolución, irradiado al hombro derecho y asociado a disnea. Mientras estaba en la sala de reanimación presenta pérdida de conciencia y usted constata que no se mueve, no respira y no tiene pulso. Además de pedir ayuda y activar el código de paro, ¿cuál es la conducta inmediata?

- a) Instalar el monitor cardíaco en modo paletas
- b) Realizar intubación orotraqueal
- c) Solicitar electrocardiograma
- d) Realizar compresiones torácicas
- e) Administrar adrenalina endovenosa en bolo

69) Un paciente de 67 años, cirrótico por consumo de alcohol, es traído por sus familiares, ya que ha presentado deterioro de su estado general y compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor superficial, tiene fétor hepático, y sus signos vitales muestran T°: 38,3°C, FC: 85x'. PA: 130/85 mmHg. El examen abdominal muestra ascitis a tensión. Presenta asterixis, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar su estudio?

- a) Hemocultivos
- b) Hemograma
- c) Estudio de líquido ascítico
- d) Tomografía axial computarizada de abdomen
- e) Ecografía abdominal

70) Un paciente de 36 años consulta por sensación de opresión precordial y tos, que son más intensas en la noche. Además, refiere disfonía y rinorrea, que se exacerbó durante la primavera. El examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar omeprazol oral
- b) Iniciar antihistamínicos orales
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Iniciar antibióticos orales
- e) Iniciar AINEs orales

71) Una paciente de 65 años, con antecedente de haber sido tratada de una úlcera duodenal hace 20 años, y de un infarto agudo al miocardio hace un año, utilizando aspirina 100 mg al día desde entonces, sufre un esguince de tobillo, por lo que se indica analgesia con diclofenco 100 mg cada 12 horas. En los días siguientes evoluciona con malestar general que va agravándose y se agrega disnea. Al examen físico presenta palidez mucocutánea, FC: 110x', PA: 110/66 mmHg, examen pulmonar normal y examen cardíaco que solo muestra taquicardia. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 7,5 g/dl, hematocrito: 23% VCM: 58 ft, plaquetas: 370.000 por mm³, ferritina: 12 ng/ml. El electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal, sin signos actuales de isquemia. ¿Cuál es el examen para proseguir el estudio etiológico?

- a) Prueba de antígeno en deposiciones para *Helicobacter pylori*
- b) Niveles de vitamina B12
- c) Biopsia de médula ósea
- d) Endoscopia digestiva alta
- e) Test de sangre oculta en deposiciones

72) Un paciente de 45 años, presenta polidipsia y poliuria de 4 semanas de evolución, asociado a baja de peso de 4 kilogramos en un mes. Al examen físico, se observa obeso con IMC: 35 y con presencia de acantosis nigricans en el cuello, sin otras alteraciones. Se solicita glicemia de ayuno, que resulta 318 mg/dl.

- a) Iniciar dieta y metformina
- b) Iniciar dieta y controlar
- c) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- d) Repetir la glicemia de ayuno
- e) Iniciar insulina

73) Una pareja consulta porque hace un año tuvieron una interrupción de un embarazo, debido a que el feto tenía anencefalia. Desde entonces ella ha tomado anticonceptivos, sin embargo, ahora quieren intentar un nuevo embarazo.. Él tiene 38 años y ella 35. Como antecedente ella tiene diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, sin tratamiento y él tiene un hermano con trisomía 21. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cariograma a ambos
- b) Iniciar levotiroxina a la mujer
- c) Solicitar espermiograma al hombre
- d) Iniciar ácido fólico 4 mg al día desde 3 meses antes al embarazo a la mujer
- e) Solicitar anticuerpos antifosfolípido a la mujer

74) Un paciente de 69 años, con daño hepático crónico, por consumo de alcohol, score de Child Pugh B, acude a control. Al examen físico tiene ascitis moderada, ictericia de piel y mucosas, sin encefalopatía. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina: 3,1 mg/dl, SGOT: 50 UI/L, SGPT: 39 UI/L, albúmina: 3,0 g/dl, FA: 110 UI/L. Se solicita una ecografía abdominal que, además de la ascitis, muestra dos lesiones hepáticas hipoeecogénicas de 2,2 cm y 1,6 cm, respectivamente. En una imagen anterior, realizada hace 6 meses, se veían las mismas lesiones, pero de menor tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Nódulos de regeneración
- b) Adenomas hepáticos
- c) Hemangiomas hepáticos
- d) Hepatocarcinomas
- e) Quistes simples hepáticos

75) Una paciente de 73 años presenta dolor abdominal moderado, en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, de 3 meses de evolución, sin otros síntomas. Al examen físico, se palpa una masa en la fosa ilíaca izquierda y, al examen ginecológico, se palpa confirma la masa anexial izquierda, de consistencia dura y 8 cm de diámetro. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Ecografía abdominal
- b) Ecografía transvaginal
- c) Resonancia magnética de abdomen y pelvis
- d) TAC de abdomen y pelvis
- e) Histerosonografía

76) Una mujer de 17 años, presenta súbitamente desviación de la cabeza hacia la derecha, cayendo al suelo. Su madre presenció el hecho y observó que mantuvo mirada conjugada hacia derecha, tras lo cual presentó hipertensión de todo el cuerpo, seguido de movimientos rítmicos de las 4 extremidades. Se recupera somnolienta y adolorida, con signos de haberse mordido la lengua, con impresión de la arcada dentaria en zona lateral de la lengua. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Crisis convulsiva primariamente generalizada
- b) Crisis focal secundariamente generalizada
- c) Síncope vasovagal
- d) Trastorno conversivo
- e) Trastorno facticio

77) Una paciente se pone un piercing en la oreja, sin embargo evoluciona con dolor y eritema, por lo que se la retira. Al sacar el piercing no ha mejorado y, en cambio, el pabellón auricular se observa eritematoso y aumentado de volumen, como se ve en la siguiente imagen (fuente:):



¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) *Streptococcus pyogenes*
- b) *Staphylococcus aureus*
- c) *Streptococcus agalactiae*
- d) *Staphylococcus epidermidis*
- e) *Pseudomonas aeruginosa*

78) Un paciente de 35 años presenta un golpe en la cabeza, debido a una caída a nivel, hace un mes. Desde entonces ha presentado reiterados episodios de vértigo intenso, de segundos de duración, que aparece con algunos movimientos de la cabeza. No tiene síntomas auditivos y su examen neurológico muestra movilidad coordinada y conservada, sin alteraciones de la marcha ni del examen de pares craneanos. Los síntomas se reproducen con las maniobras de Dix-Hallpike.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Difenidol 25 mg al día por 7 días
- b) Betahistina 8 mg cada 12 horas por 1 mes
- c) Solicitar prueba calórica
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear de troncoencéfalo y cerebro
- e) Realizar maniobras de reposición vestibular

79) Un paciente de 67 años diabético, dislipidémico e hipertenso, consulta por dolor en ambas pantorrillas, que aparece al caminar dos cuerdas, impidiéndole seguir caminando. Además, refiere dolor urente de extremidades inferiores y, al examen físico, tiene disminución de la sensibilidad táctil y termalgesia de los pies, con disminución de los reflejos rotulianos y abolición de los reflejos. ¿Cuál es el examen más adecuada para confirmar el diagnóstico?

- a) Ecografía Doppler de extremidades inferiores
- b) Electromiografía de extremidades inferiores
- c) Niveles plasmáticos de B12
- d) Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra
- e) Pletismografía de volumen de extremidades inferiores

80) Un paciente de 37 años presenta dolor en el lado derecho de la cabeza, desde hace 2 días. El día de hoy aparecen lesiones en la piel, que se muestran a continuación:



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Aciclovir 400 mg cada 6 horas, vía oral por 7 días
- b) Fluloxacilina 500 mg cada 8 horas, vía oral por 7 días
- c) Prednisona 40 mg al día, vía oral por 7 días
- d) Mupirocina en crema al 1%, aplicar cada 8 horas, por 7 días
- e) Valaciclovir 1 gramo vía oral cada 8 horas, por 7 días

81) Una mujer de 32 años, con antecedente de parto hace 8 meses, sigue dando lactancia materna a su hijo y se ha mantenido en amenorrea. No quiere embarazarse todavía, por lo que pregunta cuál es el método anticonceptivo de elección:

- a) Amenorrea de la lactancia
- b) Anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol y dienogest
- c) Anticonceptivos en parches de norelgestromina y etinilestradiol
- d) Anticonceptivos inyectables de medroxiprogesterona y estradiol
- e) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

82) Una paciente de 20 años, nuligesta, presentó relaciones sexuales sin protección hace 72 horas. Consulta porque quiere contracepción de emergencia. ¿Cuál es la más efectiva?

- a) Levonorgestrel 0,75 mg por una vez
- b) Levonorgestrel 0,75 mg ahora y 0,75 mg en 12 horas
- c) Método Yuzpe
- d) Anillo vaginal
- e) T de cobre

83) Una mujer de 52 consulta por molestias en la mama izquierda de 4 meses de evolución, caracterizados por eritema y prurito en el pezón y laaréola. Al examen físico se ve lo siguiente (Nota:aréola y pezón están eritematosos):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad de Paget de la mama
- b) Mastitis candidiásica
- c) Cáncer inflamatorio de la mama
- d) Papiloma del pezón
- e) Eccema del pezón

84) ¿En cuál de los siguientes casos se debe indicar una licencia médica tipo 1, por enfermedad o accidente común?

- a) Lumbago mecánica en trabajador de la construcción
- b) Invalidez por accidente vascular encefálico
- c) Fractura de rodilla en trayecto en bicicleta del trabajo a la casa
- d) Amigdalitis bacteriana
- e) Hospitalización por preclamsia a las 30 semanas

85) Una paciente de 45 años, obesa y fumadora consulta por parestesias progresivas en la mano derecha, que la despiertan en la noche, por lo que debe sacudir las manos para que disminuyan y desaparecen cuando frota una mano contra la otra. Refiere, además, dificultades para las actividades en las que requiere fuerza de puño, como amasar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tumor de Pancoast
- b) Síndrome del túnel carpiano
- c) Enfermedad de Dupuytren
- d) Hernia del núcleo pulposo cervical
- e) Lesión del nervio radial

86) Un paciente de 70 años consulta por aparición de una lesión pruriginosa en el párpado inferior izquierdo, que comenzó como un pequeño nódulo hace un año y que ha crecido al tamaño que se observa en la siguiente imagen (Fuente: <https://hospitaluvrocio.es/>):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Orzuelo
- b) Chalazión
- c) Melanoma
- d) Carcinoma basocelular
- e) Conjuntivitis bacteriana crónica

87) Se calcula el número de casos nuevos de un determinado cáncer en una población, durante un periodo de tiempo y se relaciona con las personas susceptibles de enfermarse de dicha enfermedad al inicio del seguimiento. ¿A qué concepto corresponde esta descripción?

- a) Incidencia acumulada
- b) Tasa de ataque
- c) Tasa de incidencia
- d) Tasa de prevalencia
- e) Tasa de letalidad

88) Una mujer de 25 años, quien mantuvo relaciones sexuales sin protección hace 3 semanas, consulta porque notó aparición de una lesión genital, que se observa como una úlcera en la horquilla vulvar. Además, se palpa una adenopatía inguinal izquierda. No ha tenido otros síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tratarla con penicilina benzatina
- b) Solicitar PCR para virus herpes simplex
- c) Tratar con fluconazol oral
- d) Tratar con aciclovir
- e) Tratar con doxicilina

89) Una paciente de 24 años, primigesta de 12 semanas, consulta porque presenta náuseas y vómitos que afectan significativamente su calidad vida. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado para el manejo inicial de esta paciente?

- a) Corticoides orales
- b) Omeprazol oral
- c) Doxilamina más piridoxina oral
- d) Metoclopramida oral
- e) Ondasentrón oral

90) Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, en tratamiento con enalapril y levotiroxina, consulta por dolor torácico intenso, que inició hace 22 horas, inicialmente con EVA 9/10, que se irradiaba al dorso y posteriormente al abdomen. Tomó analgésicos y el dolor disminuyó de intensidad, sin embargo, persiste 5/10, por lo que decidió consultar. Al examen físico, tiene FC: 98x', PA: 170/112 mmHg, pulsos de extremidades superiores conservados y disminución de los pulsos de las extremidades inferiores; examen cardíaco muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y examen pulmonar con murmullo vesicular presenta y simétrico, sin ruidos agregados. Se solicita electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Ecocardiograma transtorácico
- b) Angiografía coronaria
- c) AngioTAC de tórax y abdomen
- d) Radiografía de tórax
- e) Troponinas plasmáticas